

Información Paciente

Nombre : Cristofer Fabricio Figueroa Cáceres
Edad : 20a 2m 28d
Dirección : - Hidra 2664 D/208-D, V. San Miguel Iv

Rut : 20.792.272-2
Fecha Nacto: 08/07/2002
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1821798
Sexo : Masculino
Teléfono : 991762061

N° Epicrisis
325715

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 27/08/2022 02:55

Días Estadía : 40

Unidad de Egreso : Intermedio Quirúrgico

Fecha Egreso : 06/10/2022 17:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Herida arma de fuego

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

F.I CASR: 27/08/2022

Antecedentes mórbidos:

Policonsumo, TBC enero/2018

Cirugías: Niega

Fármacos: Niega

Alergias: Niega

Niega consumo actual de sustancias

Enfermedad Actual

Datos obtenidos de ficha médica, sin familiares al momento del ingreso.

Paciente ingreso a UEA CASR tras recibir herida por arma de fuego. Se objetiva herida maxilar, herida torácica y abdominal. Eco fast (+), por lo que se realiza TAC TAP de urgencia "Traumatismo por arma de fuego toracoabdominal. Laceraciones pulmonares derechas asociado a leve hemotórax ipsilateral. Focos de laceración hepática en segmento lateral, anterior y posterior con focos sugerentes de sangrado activo. Extenso hematoma retroperitoneal con burbujas de gas en su interior con compromiso de los espacios pararenales bilaterales. Hematoma en saco menor y omento mayor según descrito. Moderado hemoperitoneo. Proyectiles metálicos en receso costo frénico derecho, en situación pararenal anterior izquierda, a nivel ilíaco común ipsilateral y en pared abdominal de FII"

Se decide ingreso a pabellón de urgencia, protocolo quirúrgico describe:

-Hemoperitoneo 1L

-Lesión de colon ascendente de 1 cm(3) con compromiso de mesocolon

-Lesión de colon transverso de 1 cm (1)

-Lesiones de 5 mm en estómago (cara anterior 1, cara posterior 2)

-Hematoma del hilio esplénico

-Lesión de 1 cm en segmento II del hígado y de 2 cm en segmento V

-Lesión tangencial del cuerpo-cola del páncreas

Cirugía:

Laparotomía exploradora

Fecha Epicrisis : 06/10/2022 17:11

Fecha Última Actualización: 06-10-2022 17:11:13

Página 2 de 4

Colectomía derecha extendida
Esplenectomía
Packing y laparostomía
Transfusión: 5U GR - 8U crioprecipitado

Tras Cirugía, ingresa a UCI para manejo post operatorio inmediato.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

1. Shock Hipovolémico resuelto
Cirugía de Control de Daños
Colectomía derecha extendida
Esplenectomía
Packing y laparostomía
Hemoperitoneo 1L
Lesión de colon ascendente de 1 cm(3) con compromiso de mesocolon
Lesión de colon transversal de 1 cm (1)
Lesiones de 5 mm en estómago (cara anterior 1, cara posterior 2)
Hematoma del hilio esplénico
Lesión de 1 cm en segmento II del hígado y de 2 cm en segmento V
Lesión tangencial del cuerpo-cola del páncreas
2. PoliTransfusión
5UGR + 8U Crioprecipitado

EVOLUCIÓN:

Hemodinamia: Paciente ingresa en contexto de shock posterior a múltiples lesiones por bala, las cuales requieren de cirugía de emergencia el 27/08 donde se realiza colectomía derecha extendida y esplenectomía, y 28/08 en que se realiza ileostomía distal, cierre colon transversal, pancreatectomía distal e instalación de drenajes. Ingres a UPC en regulares condiciones generales, con requerimiento de DVA NAD dosis altas. Requiere de múltiples transfusiones de GR, crioprecipitado y plasma fresco congelado. Evoluciona favorablemente del punto de vista HDN logrando suspensión de DVA el 30/08. Se recontrola con TAC (30/08) ¿Significativa disminución en la extensión del hematoma retroperitoneal, Leve neumoperitoneo de distribución difusa, Disminución del hemoperitoneo, siendo en la actualidad de leve cuantía y en excavación pelviana, Múltiples laceraciones hepáticas y focos contusionales sin cambios¿.

Respiratorio: Dado condición hemodinámica del paciente se conecta a VMI con parámetros protectores. En contexto de hemoneumotórax se instala drenaje pleural derecho con TAC de control (30/08) con disminución de derrame a derecha. Se realiza prueba de ventilación espontánea favorable, por lo que se extuba el 01/09. Actualmente sin requerimientos de oxígeno.

Infeccioso: A su ingreso se inicia terapia empírica con ceftriaxona/metronidazol (FI 27/08) para cobertura de foco abdominal. El 31/08 evoluciona febril hasta 37.5°C y se rescata cultivo de líquido ascítico (+) S epidermidis, por lo que se cambia antibioterapia a ampicilina/sulbactam y se solicita OC inflamatoria, UC pendiente, CAET y HC periféricos y CVC. El 01/08 se rescatan CAET (+) K pneumoniae BLEE y sensibilidad de S epidermidis SAMR, por lo que se cambia antibioterapia a ceftazidima/avibactam, aztreonam y vancomicina Además se rescata antecedente de TBC pulmonar, por lo que se solicita PCR TBC (-).

Neurológico: Inicialmente se indica sedación con fentanil + midazolam + propofol, dado buena evolución del punto de vista hemodinámico se inicia weaning de sedación. Se solicita TAC de cerebro conversado con neurología quien refiere TAC esperado para edad. Actualmente en vigíl, sigue órdenes, tranquilo.

Quirúrgico: Se mantiene en seguimiento por equipo. Posterior a inicio de nutrición enteral evoluciona con aumento de débito de drenaje hepático, evaluado con equipo quienes refieren esperable para inicio de nutrición.

Renal: Secundario a shock evoluciona con disminución de la función renal la cual resuelve de forma precoz. Evoluciona con hipokalemia la que requiere de múltiples cargas de potasio EV.

Profilaxis: Posterior a 48 horas post pabellón se inicia tromboprofilaxis dado ausencia de evidencia de resangrado.

Fecha Epicrisis : 06/10/2022 17:11

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 06-10-2022 17:11:13

Página 3 de 4

DIAGNÓSTICOS TRASLADO UPC

Shock obs distributivo resuelto

AKI KDIGO I resuelta

Insuficiencia respiratoria resuelta

IOT 27/08

Extubado 01/09

Trauma por bala abdominal

Laparotomía exploradora 27/08

- Hemoperitoneo

- Lesión estómago, colon ascendente y transverso: Colectomía derecha extendida

- Hematoma hilio esplénico: Esplenectomía

- Packing laparoscópico

Laparoscopia exploradora 28/08

- Retiro packing

- Pancreatectomía distal

- Cierre colon transverso

- Ileostomía terminal

- Drenajes

- Cierre pared abdominal

Trauma bala torácica

Hemoneumotórax con tubo pleural

Sepsis obs foco abdominal - S epidermidis SMAR

Traqueitis por K pneumoniae BLEE NDM

Hipokalemia leve

EVOLUCIÓN INTERMEDIO QUIRÚRGICO

Paciente con lesión de tronco celíaco, evaluado por cirugía vascular se realiza intervención quirúrgica el 30/09 con rafial tronco celíaco y jareta de la aorta. Evolucionan en condiciones estables, con débitos de drenajes abdominales y pleurales a la baja, inicialmente con retiro de drenaje pleural derecho sin embargo con neumotórax al retiro razón por la cual se re-instala. Posteriormente con retiro progresivo de Jackson-Pratt, tubo pleural derecho y ambos tubos pleurales izquierdos, radiografía de control sin neumotórax.. Inicialmente con difícil manejo del dolor, es evaluado por anestesia realizando optimización de manejo. Posteriormente dolor en disminución, tolerando régimen liviano, con diuresis adecuada. Parámetros inflamatorios a la baja, sin nuevas intercorencias infecciosas. Dada evolución favorable se decide alta y control ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

AGRESION CON DISPARO DE OTRAS ARMAS FUEGO Y LAS NO ESPECIFICADAS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Buenas condiciones generales, hemodinamia estable, afebril, dolor manejado, tolerando régimen, sin uso de O2

Plan Post Alta

Reposo relativo, no realizar actividades pesadas

Régimen liviano por 1 semana

Medicamentos:

- Continuar medicamentos de uso crónico en dosis habituales

- Aspirina 100 mg al día hasta control

- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 10 días vía oral

- Ketoprofeno 50 mg, 1 comprimido cada 8 horas por 5 días vía oral

- Omeprazol 20 mg, 1 comprimido al día por 14 días vía oral, tomar en ayuno

- Tramadol 200 mg, 1 comprimido cada 12 horas por 10 días vía oral

Control con Dr. Ramos en 2 semanas en CDT pasillo 11, solicitar hora con esta epicrisis

Consultar en urgencias en caso de dolor abdominal intenso o que vaya en aumento, vómitos abundantes, dificultad respiratoria, fiebre o en caso de que estime conveniente

Fecha Epicrisis : 06/10/2022 17:11

Página 3 de 4

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Camila Andrea Olivares Romero
Becado/Residente

Camila Andrea Olivares Romero
Médico Tratante (Staff)